

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	KRITERIA MASUK DAN KELUAR NICU		
	No.Dokumen 922.6/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Suatu tatalaksana untuk menentukan prioritas bayi yang memerlukan perawatan intensif (masuk) dan menentukan kondisi bayi yang sudah stabil untuk dipindahkan ke ruang perawatan biasa (keluar).		
Tujuan	1. Memastikan pelayanan NICU diberikan kepada bayi yang paling membutuhkan (tepat sasaran) 2. Mengatur utilisasi tempat tidur NICU secara efektif 3. Menjamin keselamatan pasien melalui pengawasan ketat pada fase kritis		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 813.1/I-PDM/DIR/IX/2025 Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien		
Prosedur	A. Kriteria Masuk (Prioritas) Pasien yang diterima di NICU adalah bayi baru lahir (usia 0-28 hari) dengan kondisi sebagai berikut : 1. Prioritas 1 (Sangat Tidak Stabil) : a. Bayi yang memerlukan bantuan ventilasi mekanik (Ventilator) b. Bayi dengan gangguan hemodinamik berat yang memerlukan obat-obatan inotropik kontinyu. c. Bayi prematur ekstrem (berat < 1000 gram atau usia gestasi < 28 minggu) d. Pasca operasi besar yang memerlukan pemantauan intensif 2. Prioritas 2 (Pemantauan Ketat) : a. Bayi yang memerlukan bantuan napas non-invasif (CPAP/HFNC) b. Bayi dengan gagal napas yang berisiko memerlukan intubasi c. Bayi dengan sepsis berat atau kejang yang belum teratasi 3. Prioritas 3 (Kondisi Terminal): a. Bayi dengan penyakit kritis yang memiliki harapan hidup kecil, namun memerlukan tindakan paliatif intensif atau bantuan jangka pendek (sesuai persetujuan keluarga) B. Alur Masuk 1. DPJP atau Dokter Jaga melaporkan kondisi pasien kepada perawat NICU untuk pengecekan ketersediaan tempat tidur dan peralatan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	KRITERIA MASUK DAN KELUAR NICU		
	No.Dokumen 922.6/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	2. Perawat NICU menyiapkan unit (Inkubator/Infant Warmer, Monitor, dan alat resusitasi) 3. Serah terima pasien dilakukan menggunakan teknik SBAR antara perawat pengirim (VK/OK/IGD) dengan perawat NICU C. Kriteria Keluar Pasien dinyatakan dapat dipindahkan dari NICU ke ruang rawat inap (Level II/Perinatologi) apabila : 1. Status Respirasi Stabil : Tidak memerlukan ventilator atau CPAP, serta mampu bernapas spontan dengan atau tanpa oksigen aliran rendah 2. Status Hemodinamik Stabil: Tanda-tanda vital (Nadi, Tekanan Darah) dalam batas normal tanpa bantuan obat inotropik 3. Keseimbangan Metabolik : Tidak ada kejang dalam 24-48 jam terakhir dan hasil laboratorium (elektrolit, gula darah) stabil 4. Nutrisi : Sudah bisa mentoleransi pemberian nutrisi melalui OGT/Enteral dengan baik 5. Berat Badan: Biasanya berat badan minimal mencapai 1.500 - 1.800 gram dan suhu tubuh stabil dalam inkubator suhu kamar/boks terbuka D. Alur Keluar 1. DPJP menuliskan instruksi "Pindah Ruangan" dalam catatan medis pasien 2. Perawat memberikan edukasi kepada orang tua mengenai rencana kepindahan dan kelanjutan perawatan 3. Perawat NICU menghubungi ruangan tujuan untuk memastikan kesiapan tempat 4. Lakukan serah terima pasien dan rekam medis lengkap E. Dokumen Terkait 1. Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) 2. Formulir Transfer Pasien Internal Checklist Kelayakan Pindah Ruangan		
Unit Terkait	1. Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 2. Perinatologi 3. Instalasi Gawat Darurat (IGD)		